Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Adenotomie

Entfernung der Rachenmandel (Polypen)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Zusätzliche Eingriffe in derselben Sitzung: ☐ Tonsillektomie ☐ Paukenröhrchen ☐ Keine _____

Grund für die Operation (vom Arzt auszufüllen):
☐ Behinderte Nasenatmung / Schnarchen / Schlafapnoe
☐ Paukenerguss / wiederkehrende Mittelohrentzündungen
☐ Wiederkehrende Entzündung der Rachenmandel / Nasennebenhöhlenentzündung
_____

Sonstiges / Anmerkungen: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Die Rachenmandel (Adenoide, umgangssprachlich „Polypen“) ist lymphatisches Gewebe und Teil des körpereigenen Abwehrsystems; sie liegt hinter der Nase oberhalb des Gaumens. Besonders bei Kindern zwischen 2 und 7 Jahren kann sie sich vergrößern; ab dem Jugendalter bildet sie sich meist zurück.

Eine vergrößerte Rachenmandel kann den hinteren Nasenraum verlegen und so zu **Mundatmung, Schnarchen, Atemaussetzern im Schlaf, laufender Nase, näselnder Sprache und häufigen Infekten** führen. Da sie auch die Öffnung der Ohrtrompete (Tube) verlegen kann, die das Ohr mit dem hinteren Nasenraum verbindet, kann sie **Flüssigkeit im Mittelohr (Paukenerguss), Schwerhörigkeit und wiederholte Mittelohrentzündungen** verursachen. Eine lange bestehende Mundatmung kann außerdem die Entwicklung von Gesicht und Zähnen beeinflussen.

Ziel der Adenotomie ist es, das vergrößerte Rachenmandelgewebe zu entfernen, um die Nasenatmung zu erleichtern und Beschwerden an Ohren, Nasennebenhöhlen und Atemwegen zu verringern. Ihr Arzt wird Ihnen gesondert erklären, warum diese Operation für Sie oder Ihr Kind empfohlen wurde.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird in Vollnarkose im Operationssaal durchgeführt. Sie erfolgt durch den Mund; **es gibt keine Schnitte oder Narben von außen.**

1. **Vorbereitung:** Nach Einleitung der Narkose wird ein spezielles Instrument eingesetzt, das den Mund offen hält, und das Gaumensegel wird behutsam angehoben, damit der hintere Nasenraum sichtbar wird.
2. **Entfernung der Rachenmandel:** Die Rachenmandel wird mit einer Kürette (einem speziellen Schabinstrument), einem endoskopisch geführten Shaver (Mikrodebrider), mit Coblation oder mit Elektrokoagulation aus dem hinteren Nasenraum entfernt. Da die Rachenmandel ein Gewebe und kein abgegrenztes Organ ist, kann sie nicht „mit der Wurzel" entfernt werden; Ziel ist es, den Anteil, der die Verlegung verursacht, sicher zu entfernen.
3. **Blutstillung:** Auf das Wundgebiet wird für kurze Zeit mit einem Tupfer Druck ausgeübt, und bei Bedarf wird die Blutung mit Elektrokoagulation gestillt. Am Ende der Operation wird keine Tamponade im hinteren Nasenraum belassen.
4. **Zusätzliche Eingriffe:** Falls geplant, werden in derselben Narkose die Gaumenmandeln entfernt (Tonsillektomie) oder Paukenröhrchen in die Trommelfelle eingesetzt. Für diese Eingriffe werden gesonderte Aufklärungsbögen ausgefüllt.
5. **Aufwachen:** Nach der Operation wird die Patientin / der Patient im Aufwachraum engmaschig überwacht, bis sie bzw. er vollständig wach ist.

Hält der Arzt es für notwendig, wird das entfernte Gewebe zur feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung eingesandt.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose	Etwa 20–30 Minuten (ohne Narkosezeit)	Meist Entlassung am selben Tag; bei Bedarf eine Nacht zur Beobachtung

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Freiere Nasenatmung, weniger Schnarchen und weniger Atemaussetzer im Schlaf
- Besserer Schlaf und dadurch verbesserte Aufmerksamkeit, besseres Verhalten und bessere Schulleistungen am Tag
- Weniger Paukenergüsse und Mittelohrentzündungen, was zur Verbesserung des Hörens beiträgt
- Weniger Nasenausfluss sowie weniger Nasennebenhöhlenentzündungen und Infekte der oberen Atemwege

Bei sorgfältig ausgewählten Patientinnen und Patienten bessern sich Nasenatmungsbehinderung und Schnarchen in der großen Mehrzahl der Fälle deutlich. Hat die Behinderung jedoch zusätzlich andere Ursachen – etwa eine Allergie, vergrößerte Nasenmuscheln oder eine verkrümmte Nasenscheidewand –, verschwinden die Beschwerden möglicherweise nicht vollständig. Der Erfolg bei Ohrproblemen hängt auch von der Entwicklung der Ohrtrompete ab; manche Kinder benötigen eine weitere Behandlung oder Paukenröhrchen.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Abwartendes Beobachten:** Sind die Beschwerden gering, kann mit regelmäßigen Kontrollen abgewartet werden, da sich die Rachenmandel mit zunehmendem Alter zurückbildet.
- **Medikamente:** Kortisonhaltige Nasensprays können bei manchen Kindern die Schwellung der Rachenmandel und die Verlegung vorübergehend verringern; besteht eine Allergie, wird diese behandelt. Die Wirkung hält in der Regel nur so lange an, wie das Medikament angewendet wird.
- **Bei Ohrproblemen nur Paukenröhrchen:** In manchen Fällen kann erwogen werden, Röhrchen in die Trommelfelle einzusetzen, ohne die Rachenmandel zu entfernen.
- **Andere Möglichkeiten bei Schlafapnoe:** In sehr seltenen Fällen, in denen eine Operation nicht geeignet ist, kann im Schlaf ein Überdruckbeatmungsgerät (CPAP) verwendet werden.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird die Operation nicht durchgeführt, kann sich die Rachenmandel im Jugendalter von selbst zurückbilden. Bis dahin können jedoch Mundatmung, Schnarchen, schlechter Schlaf, wiederkehrende Infekte und Schwerhörigkeit durch Flüssigkeit im Ohr fortbestehen. Lang andauernde und schwere schlafbezogene Atmungsstörungen können bei Kindern zu verzögertem Wachstum und verzögerter Entwicklung, Aufmerksamkeits- und Verhaltensproblemen und selten zu einer Belastung von Herz und Lunge führen. Ein lange bestehender Paukenerguss kann die Sprachentwicklung beeinträchtigen und bleibende Veränderungen am Trommelfell verursachen.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen (insbesondere Blutungs- und Gerinnungstests) und gegebenenfalls weitere notwendige Untersuchungen durchgeführt, und Sie werden vom Narkosearzt untersucht.
- Bitte teilen Sie uns mit, wenn in der Familie eine Neigung zu Blutungen oder blauen Flecken oder eine Blutgerinnungsstörung bekannt ist.
- **6 Stunden** vor der Operation dürfen keine feste Nahrung und keine Milch gegeben werden; für klare Flüssigkeiten gilt die vom Narkosearzt angegebene Zeit.
- Bitte teilen Sie uns mit, wenn in den 2–3 Wochen vor der Operation Fieber, Durchfall, Husten oder eine Grippe aufgetreten sind; die Operation muss dann möglicherweise verschoben werden.
- Wenn ein Milchzahn wackelt, sagen Sie es bitte Ihrem Arzt, da er während der Narkose herausfallen könnte.
- Wir empfehlen, Ihr Kind mit altersgerechten Worten, die ihm keine Angst machen, auf die Operation vorzubereiten.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Operationstag	Nach dem Aufwachen können leichte Halsschmerzen, blutig tingierter Schleim aus der Nase und Mundatmung auftreten. Erbrechen oder leicht erhöhte Temperatur sind möglich. Sobald eine eventuelle Übelkeit abgeklungen ist, wird zuerst Wasser gegeben, danach lauwarme, weiche Speisen. Die meisten Patientinnen und Patienten gehen am selben Tag nach Hause.
Erste 3–5 Tage	Behinderte Nasenatmung und Schnarchen können wegen der Schwellung noch bestehen; Mundgeruch, leicht erhöhte Temperatur, Ohren- und Nackenschmerzen sind möglich. Die Schmerzen sind meist gering und lassen sich mit den von Ihrem Arzt empfohlenen Schmerzmitteln behandeln. Es ist wichtig, reichlich zu trinken.
1. Woche	Die meisten Kinder können innerhalb von 3–7 Tagen wieder in die Schule oder den Kindergarten gehen, Erwachsene wieder arbeiten. Meiden Sie in der ersten Woche Menschenansammlungen und Personen mit Infekten.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2.–4. Woche	Mit dem Abklingen der Schwellung wird die Nasenatmung deutlich freier. Eine eventuelle vorübergehende näselnde Sprache bildet sich meist in diesem Zeitraum zurück. Schwimmen und anstrengender Sport sind in der Regel nach 2 Wochen erlaubt.
1.–3. Monat	Es erfolgt eine Kontrolluntersuchung; wurde die Operation wegen Ohrproblemen durchgeführt, werden die Ohren mit einem Hörtest und einer Tympanometrie überprüft.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Leichte Halsschmerzen und Beschwerden beim Schlucken
- Einige Tage lang blutig tingierter Schleim aus der Nase und behinderte Nasenatmung
- Mundgeruch (durch die heilende Wundfläche; klingt innerhalb von 1–2 Wochen ab)
- Ohrenschmerzen (ausstrahlende Schmerzen über gemeinsame Nerven; sie bedeuten nicht, dass ein Problem im Ohr vorliegt)
- Leicht erhöhte Temperatur (in den ersten 1–2 Tagen), Übelkeit und Erbrechen durch die Narkose

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Vorübergehend näselnde Sprache** — Nach Entfernung der Rachenmandel braucht der Gaumen Zeit, um sich anzupassen; beim Sprechen kann für einige Tage bis einige Wochen Luft durch die Nase entweichen, und gelegentlich können Flüssigkeiten durch die Nase zurückfließen. Dies bildet sich meist innerhalb von 1–2 Monaten von selbst zurück.
- **Nackenschmerzen und Steifigkeit** — Wegen der Lagerung während der Operation und der Wundheilung im hinteren Nasenraum können Bewegungen des Halses in den ersten Tagen schmerzhaft sein; dies klingt meist innerhalb weniger Tage ab.
- **Beschwerden bessern sich nicht vollständig** — Bestehen zusätzliche Ursachen wie Allergie, vergrößerte Nasenmuscheln oder eine verkrümmte Nasenscheidewand, kann die Nasenatmungsbehinderung teilweise fortbestehen; eine weitere Behandlung kann notwendig sein.

Gelegentliche Beschwerden

- **Blutung** — Eine deutliche Nachblutung tritt bei **weniger als 1 von 100 Patientinnen und Patienten (etwa 0,5–1 von 100)** auf. Sie tritt meist in den ersten 24 Stunden auf. Lässt sich die Blutung nicht stillen, kann **eine erneute Operation in Vollnarkose zur Blutstillung** notwendig werden. Eine Bluttransfusion ist nur sehr selten erforderlich.
- **Zahnschäden** — Durch den Druck des Instruments, das den Mund offen hält, kann ein Zahn abbrechen oder sich lockern bzw. herausfallen, besonders ein bereits wackelnder oder kariöser Zahn.
- **Verletzung oder Schwellung von Lippen, Zunge oder Gaumen** — Durch den Kontakt mit den Instrumenten können kleine Wunden oder vorübergehende Schwellungen entstehen; sie heilen innerhalb weniger Tage ab.
- **Infektion** — Kann sich durch steigende Temperatur, zunehmenden Mundgeruch und zunehmende Schmerzen bemerkbar machen; sie bessert sich in der Regel mit Antibiotika.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Nachwachsen der Rachenmandel** — Rachenmandelgewebe kann nachwachsen (bei etwa **1–5 von 100** Patientinnen und Patienten), besonders bei Kindern, die sehr früh operiert wurden, und bei Menschen mit Allergien. Kehren die Beschwerden zurück, kann selten eine erneute Operation notwendig sein.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Dauerhaft näselnde Sprache / Rückfluss von Flüssigkeiten durch die Nase (velopharyngeale Insuffizienz)** — Tritt bei etwa **1 von 1.500–3.000** Patientinnen und Patienten auf; das Risiko ist höher bei Kindern mit einer verdeckten Gaumenspalte (submuköse Gaumenspalte). Sie bessert sich meist durch logopädische Behandlung (Sprachtherapie); selten kann eine Korrekturoperation notwendig sein. Deshalb wird der Gaumen vor der Operation sorgfältig untersucht.
- **Verschiebung der Halswirbel (Grisel-Syndrom)** — Eine **sehr seltene** Erkrankung, bei der eine Entzündung im hinteren Nasenraum die Bänder der oberen Halswirbel in Mitleidenschaft zieht. Sie äußert sich durch Nackenschmerzen, die in den Tagen nach der Operation beginnen und stetig zunehmen, die Unfähigkeit, den Kopf zu drehen, und eine Schiefhaltung des Kopfes zu einer Seite. Wird sie früh erkannt, wird sie mit Medikamenten und einer Halskrause behandelt; bei verzögerter Diagnose können eine längere Behandlung oder selten eine Operation notwendig werden, und eine dauerhafte Einschränkung der Halsbeweglichkeit kann zurückbleiben. Stetig zunehmende Nackenschmerzen müssen daher immer gemeldet werden.
- **Vernarbung oder Verengung im hinteren Nasenraum** — Sehr selten, besonders wenn zusammen mit einer Tonsillektomie ausgedehnt Gewebe entfernt wird, kann sich während der Heilung eine Verengung im hinteren Nasenraum bilden; diese kann die Nasenatmung behindern und eine weitere Behandlung erfordern.
- **Schwere Blutung und ihre Folgen** — Äußerst selten kann bei einem ungewöhnlich verlaufenden Blutgefäß oder einer unerkannten Gerinnungsstörung eine schwere Blutung auftreten. In diesem Fall können eine Notoperation, eine Bluttransfusion und eine Behandlung auf der **Intensivstation** notwendig werden; Blut, das in die Atemwege gelangt, kann Atemprobleme verursachen.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Frisches, hellrotes Blut** aus Mund oder Nase, Ausspucken oder Erbrechen von Blut (jede Blutung, die über ein paar Tropfen hinausgeht, sollte gemeldet werden)
- Häufiges Schlucken (bei Kindern ein wichtiges Zeichen dafür, dass Blut verschluckt wird), Blässe, Schwäche
- **Fieber über 38,5 °C** oder Fieber, das trotz Schmerzmitteln nicht zurückgeht
- Gar kein Trinken, seit 6–8 Stunden kein Urin, ungewöhnliche Schläfrigkeit (Zeichen von Flüssigkeitsmangel)
- Stetig zunehmende **Nackenschmerzen**, Unfähigkeit, den Kopf zu drehen, oder Schiefhaltung des Kopfes zu einer Seite
- Atembeschwerden oder deutliche Atemaussetzer im Schlaf

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Verwenden Sie gegen Schmerzen nur **die von Ihrem Arzt empfohlenen Schmerzmittel**; Aspirin und aspirinhaltige Medikamente dürfen nicht eingenommen werden, da sie Blutungen verstärken können.
- In den ersten Tagen werden lauwarme oder kühle, weiche Speisen und **reichlich Flüssigkeit** empfohlen; meiden Sie sehr heiße, harte und scharf gewürzte Speisen.
- Schnäuzen Sie in der ersten Woche nicht kräftig.
- Ist in der ersten Woche nach der Operation ein Rückflug ins Ausland geplant, besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ab wann ein Flug frühestens unbedenklich ist; wegen des Blutungsrisikos empfiehlt es sich, in den ersten Tagen in erreichbarer Nähe Ihres Arztes zu bleiben.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.
- ☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Mir wurde erklärt, dass ich in den ersten Tagen nach der Operation, insbesondere bei meinem Kind, auf Anzeichen einer Blutung (häufiges Schlucken, Ausspucken oder Erbrechen von Blut) achten und mich an den Arzt wenden muss.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

- ☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.
- ☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.